



INFORMACIÓN GENERAL		
Fecha de Impresión: 07/09/2026 16:21	Fecha de Atención: 04/09/2024 11:19	Impreso por: AMRANDA
Centro de atención: Z01 - Zaragoza	Admisión: AD998670	
Paciente: CC 73077403 - JOSE LUIS ESTARITA FERRER		Sexo: M
Fecha de Nacimiento: 03/03/1976	Edad: 48 año(s), 6 mes(es) 1 día(s)	Estado Civil: Soltero
Religión:	Creencia:	
Régimen: 2 - Subsidiado	Nivel: 1	Carnet:
Dirección: CALLE JOSE MARIA PASO PASEO BOLIVAR #17-49	Lugar: Cartagena Bolívar	
Teléfono: 6725967		
Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION		
Grupo Poblacional:	Raza:	Etnia:
Acompañante: WILLIAN ASPRILLA	Parentesco Acomp.:	
Teléfono Acomp.:		
Dirección Acomp.:	Parentesco Resp.: ACOMPAÑANTE	
Responsable:		
Teléfono Resp.:	Parentesco Resp.: ACOMPAÑANTE	
Dirección Resp.:	Especialidad: MEDICINA INTERNA	
Médico Tratante: JORGE ARMANDO YEPES CARO		Tipo Vinculación:
Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A		

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias
Fecha de Ingreso: 02/09/2024 12:08
Cama: CM446
Motivo de la Consulta:
"no puedo comer - me duele para tragar - me siento débil no tengo fuerza para caminar"

ANTECEDENTES:

* 1-> NIEGA

* 5-> PACIENTE REFIERE QUE CONSUMIA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (MARIHUANA), EX FUMADOR

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD EN MAL ESTADO MUSCULONUTRICIONAL CON ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO DE LARGA DATA DADO POR ASTENIA DISFAGIA ANOREXIA DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y TOS CON EXPECTORACION VERDOSA, ESCALOFRIOS ASOCIADO A PERDIDA DE PESO EN LOS ULTIMOS 4 MESES (NO RECUERDA CUANTO PESABA ANTES) MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA, ACTUALMENTE PACIENTE EN ESTABLES CONDICIONES GENERALES CONCIENTE ALERTA, CIFRAS TENSIONALES EN META, TAQUICARDICO, SATURANDIO 97% A OXIGENO AMBIENTE, A NIVEL PULMONAR MURMULLO VESICULAR PRESENTE SIN SOBREAgregados. SE INGRESA PACIENTE EN CONTEXTO DE POSIBLE TBC A DESCARTAR. SE SOLICITAN PARACLINICOS DE EXTENSION Y REVALORAR CON RESULTADOS. EXPLICO A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

PACIENTE QUIEN FIRMA ALTA VOLUNTARIA. SE EXPLICA CUADRO Y POSIBLES COMPLICACIONES.

Revisión Por Sistema:

SISTEMA RESPIRATORIO

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

PACIENTE INGRESA EN ESTABLES CONDICIONES GENERALES, CONCIENTE, ALERTA, MAL ESTADO MUSCULONUTRICIONAL,

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCÉFALO, ISOCÓRIAS, NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTERICAS, NARINAS PERMEABLES, MUCOSA ORAL HÚMEDA SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SIMÉTRICO, SIN MASAS NI ADENOMEGALIAS, ARCOS DE MOVIMIENTO NORMALES. NO INGURGITACIÓN YUGULAR.

Tórax:

SIMÉTRICO, PULMON CON MURMULLO VESICULAR PRESENTE. RUIDOS CARDIACOS TAQUICARDICOS, RÍTMICOS DE BUEN TONO E INTENSIDAD. SIN SOPLOS

Abdomen:

ABDOMEN PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL NI PROFUNDA SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS. PUÑO PERCUSIÓN LUMBAR NEGATIVAS

Piel y faneras:

SIN LESIONES EVIDENTES

Genito-Urinario:

NO EXPLORADO

Extremidades:

SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, PULSOS DISTALES PRESENTES. LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS

Sistema nervioso central:

SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE, PARES CRANEALES SIN ALTERACIONES, AUSENCIA DE SIGNOS MENINGEOS FUERZA MUSCULAR 5/5 EN TODAS LAS EXTREMEIDADES. GLASGOW COMA ESCALA 15/15

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:19:32 p. m.

Admisión: AD998670

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: JOSE LUIS ESTARITA FERRER

EPICRISIS

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD EN MAL ESTADO MUSCULONUTRICIONAL CON ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO DE LARGA DATA DADO POR ASTENIA DISFAGIA ANOREXIA DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y TOS CON EXPECTORACION VERDOSA, ESCALOFRIOS ASOCIADO A PERDIDA DE PESO EN LOS ULTIMOS 4 MESES (NO RECUERDA CUANTO PESABA ANTES) MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA ACTUALMENTE PACIENTE EN ESTABLES CONDICIONES GENERALES CONCIENTE ALERTA, CIFRAS TENSIONALES EN META, TAQUICARDICO, SATURANDIO 97% A OXIGENO AMBIENTE, A NIVEL PULMONAR MURMULLO VESICULAR PRESENTE SIN SOBREGREGADOS. SE INGRESA PACIENTE EN CONTEXTO DE POSIBLE TBC A DESCARTAR. SE SOLICITAN PARA CLINICOS DE EXTENSION Y REVALORAR CON RESULTADOS. EXPLICO A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal: R13X: DISFAGIA

Diagnóstico Relacionado 1: J22X: INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES

EVOLUCIONES:

Fecha: 02/09/2024: 17:10:58, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: MLCIADES ANTONIO OLIVEROS CAMARGO, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: EVOLUCION

Descripción: Fecha de Ingreso :02/09/2024 No. Documento Identidad:CC 73077403Apellidos y Nombres:ESTARITA FERRER JOSE LUIS No. Ingreso:7 70024501902210: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCIITOS AUTOMATIZADO Método: Citometría de Flujo/Citoquímica/Dispersión de Luz Analizador:CELLDYN RUBI-ABBOTT LEUCOCITOS 7.71 x10³/mm³ 4.0 11.0NEUTROFILOS% 73.1 % 45.0 75.0NEUTROFILOS# 5.64 x10³/mm³ 4.50 7.00LINFOCITOS% 21.8 % 20.0 45.0LINFOCITOS# 1.68 x10³/mm³ 1.50 4.50MONOCITOS% 4.5 % 1.00 8.00MONOCITOS# 0.35 x10³/mm³ 0.00 0.80EOSINOFILOS% 0.36 % 1.00 6.00EOSINOFILOS# 0.03 x10³/mm³ 0.00 0.45BASOFILOS% 0.25 % 0.00 1.00BASOFILOS# 0.02 x10³/mm³ 0.00 0.20ERITROCITOS 3.33 x10⁶/mm³ 4.0 4.8HEMOGLOBINA 8.7 gr/dl 12.0 16.0HEMATOCRITO 27.0 % 36.0 48.0 INDICES HEMATICOS Volumen Corpuscular Medio (VCM): 81.1 um³ 80.0 100.0Hemoglobina Corpuscular Media(HCM): 26.0 pg 26.5 32.0Concentracion Hb.Corp.Media (CCMH): 32.0 gr/dl 32.0 36.0Ancho Distrib. Eritrocitos (IDE): 12.8 % 11.5 15.0 SERIE PLAQUETARIAPlaquetas (PLT): 318 10³xmm³ 150 450Volumen Plaquetario Medio (VPM): 3.87 um³ 6.5 11.0Plaquetocrito (PTC): 0.12 % 0.100 0.500Ancho Distrib. de Plaq.(PDW): 16.55 % 25 65Validado por:MARIA Fecha Validación:02/09/2024903859: POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOSPOTASIO EN SUERO.....: 3.9 mmol/L VRef: 3.6-5.5 mmol/L Método: Ion Selectivo Analizador: Dimension Rxl MAX Siemens 903813: CLOROCOLOR EN SANGRE.....: 97 mmol/L VRef: 98-107 Método: Ion Selectivo Analizador: Dimension Rxl MAX Siemens 903864: SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOSSODIO EN SUERO: 131 mmol/L VRef: 136-145 mmol/L Método: Ion Selectivo Analizador: Dimension Rxl MAX Siemens 903895: CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOSCREATININA EN SUERO.....: 0.62 mg/dl 0.55 1.30Método: Jaffé cinética modificada VRef: Hombres: 0.70-1.30 mg/dl Mujeres: 0.55-1.02 mg/dl Analizador: Dimension Rxl MAX Siemens 903856: NITRÓGENO UREICONITRÓGENO UREICO (BUN).....: 12 mg/dl Método: Ureasa VRef: Adultos: 7-18 mg/dl Niños: 5 - 18 Analizador: Dimension Rxl MAX Siemens Validado por:CARMEN Fecha Validación:02/09/2024906913: PROTEÍNA C REACTIVA ALTA PRECISIÓN AUTOMATIZADOPROTEÍNA C REACTIVA ALTA PRECISIÓN 10.4 mg/dl Método: Turbidimétrico VRef: 0.00 - 0.30 mg/dl Analizador: Dimension Rxl MAX Siemens Validado por:CARMEN Fecha Validación:02/09/2024902049: TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]: 31.0 segundos Método: Coagulometría Analizador: CA 660 VRef: 23.5 - 34.3 Control: 28.7 segundos 902045: TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]: 12.4 segundos Método: Coagulometría Analizador: CA 660 VRef: 9.7 - 14.0 Control: 10.9 segundos INR: 1.1 Validado por:MARIA Fecha Validación:02/09/2024FALTANDO BASILOSCOPIA

Fecha: 02/09/2024: 17:26:44, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: MLCIADES ANTONIO OLIVEROS CAMARGO, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: EVOLUCION

Descripción: Motivo de consulta" no puedo comer - me duele para tragar - me siento débil no tengo fuerza para caminar "Enfermedad actual:PACIENTE MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD EN MAL ESTADO MUSCULONUTRICIONAL CON ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUIEN INGRESA POR CUADRO CLINICO DE LARGA DATA DADO POR ASTENIA DISFAGIA ANOREXIA DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y TOS CON EXPECTORACION VERDOSA, ESCALOFRIOS ASOCIADO A PERDIDA DE PESO EN LOS ULTIMOS 4 MESES (NO RECUERDA CUANTO PESABA ANTES) MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA, ACTUALMENTE PACIENTE EN ESTABLES CONDICIONES GENERALES CONCIENTE ALERTA, CIFRAS TENSIONALES EN META, TAQUICARDICO, SATURANDIO 97% A OXIGENO AMBIENTE, A NIVEL PULMONAR MURMULLO VESICULAR PRESENTE SIN SOBREGREGADOS. SE INGRESA PACIENTE EN CONTEXTO DE POSIBLE TBC A DESCARTAR. SE SOLICITAN PARA CLINICOS DE EXTENSION Y REVALORAR CON RESULTADOS. EXPLICO A PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTARPACIENTE QUIEN SE REVALORA CON IMAGENES RX PATOLOGICA PARA UNA TBC PULMONAR., SE SOLICITA EL CONCURSO., DE MEDICINA INTERNA., PARA VALORACION., TTO Y CONDUCTA

Fecha: 03/09/2024: 11:03:13, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: MELKIS ANTONIO BUEL VAS VILLALBA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar
2. Anemia moderada normocítica normocrómica
3. Hiponatremia leve
4. Catarata en ojo izquierdo
5. Consumo de sustancias psicoactivas
6. Síndrome Anémico por déficit de hierro

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse bien, niega alzas térmicas, niega disnea u otros síntomas. Persiste con tos húmeda

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

Signos vitales: PA 125/78 mmHg, FC 70 lpm, FR 19 rpm, T 36.9°C, SpO2 97% a aire ambiente

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, pupila derecha normorreactiva a la luz, izquierda no reactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en regular estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobregregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos.

Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

Análisis:

Paciente en la quinta década de la vida sin antecedentes de importancia quien consulta por cuadro mal referenciado, pues paciente es mal informante y sin

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:19:32 p. m.

Admisión: AD998670

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: JOSE LUIS ESTARITA FERRER

EPICRISIS

conciencia de enfermedad, aparenta al menos 4 meses de evolución dado por disnea que aumenta paulatinamente asociada a accesos de tos húmeda ocasional, niega picos febriles, sin embargo refiere pérdida de peso progresiva, con antecedente no claro de consumo de sustancias psicoactivas. En ronda médica, en regular estado general, signos vitales en metas, buen patrón respiratorio, normosaturado a oxígeno ambiente, sin embargo taquipneico. Cuenta con laboratorios que evidencian hemograma con anemia normocrómica normocítica, que de acuerdo a perfil ferrocínético se confirma por déficit de hierro sin otra alteración en demás líneas, PCR elevada, perfil renal en parámetro de normalidad, ionograma con hiponatremia leve, resto en valores de normalidad; se recibe reporte de radiografía de tórax con presencia de infiltrados difusos bilaterales, junto a atelectasia en ápice derecho en diferencial con consolidación en diferencial con cavitación hidroaérea, por lo que se decide no iniciar cubrimiento antibiótico a espera de visualización de la TAC debido a que el paciente no ha presentado alzas térmicas, tiene buena mecánica respiratoria, no tiene respuesta inflamatoria en paraclínicos. Teniendo en cuenta lo anterior considero paciente con sospecha de tuberculosis pulmonar, se indica hospitalización en aislamiento respiratorio. Paciente se niega a procedimiento para toma de muestras por lo que no se hizo posible la serología para VIH y resto de paraclínicos controles, por lo que se decide adicionar valoración por el servicio de psicología, trabajo social para definir conductas adicionales. Se explica a paciente diagnóstico y conducta a seguir, refieren entender y aceptar.

Fecha: 04/09/2024: 10:26:21, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JORGE YEPES CARO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar con criterio imagenológico
2. Anemia ferropénica moderada normocítica normocrómica
3. Hiponatremia leve
4. Catarata en ojo izquierdo
5. Consumo de sustancias psicoactivas
6. Síndrome Anémico por déficit de hierro

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse bien, niega alzas térmicas, niega disnea u otros síntomas. Persiste con tos húmeda.

Objetivo:

PA 95/65 mmHg, FC 90 lpm, FR 19 rpm, T 36.9°C, SpO2 97% a aire ambiente

Luce en regular estado general, regular estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, pupila derecha normorreactiva a la luz, izquierda no reactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en regular estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos.

Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

02/09/2024:

TP 12.4 TTP 31

HB 8.7 HTO 27 VCM 81.1 LEU 7.71 NEU 73.1 PLAT 318

BUN 12 CRE 0.62

CL 97 K 3.9 NA 131

PCR 10.4

VDRL NO REACTIVO

HIERRO 14 SAT TRANSFERRINA 11.29

LDH 365

AST 10 ALT 12

BT 0.37 BD 0.2 BI 0.17

IMÁGENES

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX AP:

Información Clínica: Paciente con disfagia.

Siluetas cardíaca de configuración izquierda.

Tráquea centrada.

Radioopacidades alveolares hacia los lóbulos superiores y lóbulo medio de probable etiología infecciosa.

Se observan algunos tractos fibrosos hacia los ápices pulmonares con retracción de los hilios.

Senos costofrénicos libres.

Las estructuras óseas visualizadas sin hallazgos a mencionar.

Se sugiere complementar con tomografía computada.

Análisis:

Paciente en la quinta década de la vida sin antecedentes de importancia, hospitalizado en contexto de sospecha de tuberculosis pulmonar, con antecedente no claro de consumo de sustancias psicoactivas. En ronda médica, en regular estado general, signos vitales en metas, buen patrón respiratorio, normosaturado a oxígeno ambiente. Cuenta con laboratorios que evidencian hemograma con anemia normocrómica normocítica, que de acuerdo a perfil ferrocínético se confirma por déficit de hierro sin embargo se difiere reposición por infección activa; reporte de radiografía de tórax con presencia de infiltrados difusos bilaterales, junto a atelectasia en ápice derecho en diferencial con consolidación en diferencial con cavitación hidroaérea, paciente sin aislamiento microbiano, sin embargo por alto riesgo de contagio, paciente quien se niega a uso de tapabocas y no se encuentra en aislamiento, se inicia RIPE dada imagen típica de tuberculosis, se solicitan estudios de extensión, a la espera de valoración por psicología y trabajo social, ya que paciente se niega a toma de muestras para laboratorios, a la espera de tomografía de tórax, se insistirá en aislamiento microbiológico. Se explica a paciente diagnóstico y conducta a seguir, refiere entender y aceptar.

Fecha: 04/09/2024: 11:18:04, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JORGE YEPES CARO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE QUIEN FIRMA ALTA VOLUNTARIA. SE EXPLICA CUADRO Y POSIBLES COMPLICACIONES.

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN FIRMA ALTA VOLUNTARIA. SE EXPLICA CUADRO Y POSIBLES COMPLICACIONES.

Objetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:19:32 p. m.

Admisión: AD998670

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: JOSE LUIS ESTARITA FERRER

EPICRISIS

PACIENTE QUIEN FIRMA ALTA VOLUNTARIA. SE EXPLICA CUADRO Y POSIBLES COMPLICACIONES.

Análisis:

PACIENTE QUIEN FIRMA ALTA VOLUNTARIA. SE EXPLICA CUADRO Y POSIBLES COMPLICACIONES.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Fecha: 02/09/2024

-906249 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS- Cantidad: 1
 -903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1
 -879301 - TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX - Cantidad: 1
 -906915 - PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL (VDRL) - Cantidad: 1
 -903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1
 -902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
 -901101 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEELEN] - Cantidad: 1
 -903828 - DESHIDROGENASA LACTICA - Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -903813 - CLORO - Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1
 -908825 - Mycobacterium tuberculosis IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA - Cantidad: 1
 -903016 - FERRITINA - Cantidad: 1
 -871121 - RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) - Cantidad: 1
 -903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
 -903846 - HIERRO TOTAL - Cantidad: 1
 -903044 - SATURACIÓN DE TRANSFERRINA - Cantidad: 1
 -902045 - TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] - Cantidad: 1
 -903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1
 -901230 - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO - Cantidad: 1
 -902049 - TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] - Cantidad: 1
 -906913 - PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO - Cantidad: 1
 -903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 03/09/2024

-903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) - Cantidad: 1

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha: 02/09/2024

Indicaciones:

PLAN
 OBSERVACION
 TAPABOCAS N95 PERMANENTE
 HARTMAN 500 CC BOLO AHORA
 PARACETAMOL 1GR IV AHORA LENTO
 S/S RADIOGRAFIA TORAX PA Y LAT
 S/S HEMOGRAMA, IONOGRAMA, PCR, BUN, CREATININA, TP, PTP, BACILOSCOPIA SERIADA,
 CUIDADOS DE ENFERMERIA
 CONTROL DE SIGNOS VITALES
 AVISAR CAMBIOS

Fecha: 02/09/2024

Indicaciones:

- Hospitalizar en sala de infectología
 - Aislamiento respiratorio mascarilla N95 permanente
 - Oxígeno por cánula nasal a 3L/Mn si SPO2 < 92%
 - Dieta corriente
 - Tapon venoso
 - Paracetamol 1gr IV cada 8 horas
 - SS/PCR para tuberculosis, cultivo para tuberculosis en medio líquido, VDRL, VIH, hierro serico, ferritina, saturacion de transferrina, Idh, tgo, tgp, bilirrubinas.
 - SS/Tomografia de torax
 - P/Baciloscopia seriada
 - Cuidados de enfermería
 - Control de signos vitales y avisar cambios

Fecha: 03/09/2024

Indicaciones:

- Hospitalizar en sala de infectología
 - Aislamiento respiratorio mascarilla N95 permanente
 - Oxígeno por cánula nasal a 3L/Mn si SPO2 < 92%
 - Dieta corriente
 - Tapón venoso

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:19:32 p. m.

Admisión: AD998670

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: JOSE LUIS ESTARITA FERRER

EPICRISIS

- Paracetamol 1gr IV cada 8 horas
- Enoxaparina 40 Mg/subcutanea cada 24 h:::Nuevo:::

- SS/ Gases arteriales
- P/PCR para tuberculosis, cultivo para tuberculosis en medio líquido, VH, ferritina
- P/Tomografía de torax
- P/Baciloscopia seriada
- Cuidados de enfermería
- Control de signos vitales y avisar cambios

Fecha: 03/09/2024

Indicaciones:

- Hospitalizar en sala de infectología
- Aislamiento respiratorio mascarilla N95 permanente
- Oxígeno por cánula nasal a 3L/Min si SPO2 < 92%
- Dieta corriente
- Tapon venoso

- Paracetamol 1gr IV cada 8 horas
- Enoxaparina 40 Mg/subcutanea cada 24 h:::Nuevo::: FS:03/09/2024

- Valoración por psicología, trabajo social FS: 03/09/2024 :::NUEVO:::

- SS/ Gases arteriales(paciente no se deja tomar muestra) :::NUEVO:::
- P/ PCR para tuberculosis, cultivo para tuberculosis en medio líquido, VH(paciente no se deja tomar la muestra), tgo, tgp.
- P/ Tomografía de torax
- P/Baciloscopia seriada

- Cuidados de enfermería
- Control de signos vitales y avisar cambios

Fecha: 04/09/2024

Indicaciones:

- Hospitalizar en sala de infectología
- Aislamiento respiratorio mascarilla N95 permanente
- Oxígeno por cánula nasal a 3L/Min si SPO2 < 92%
- Dieta corriente
- Tapon venoso

- Rifampicina 150 mg + Isoniazida 75 mg + Pirazinamida 400 mg + Etambutol 275 mg tableta, administrar 3 tabletas VO cada día (FI: 04/09/2024) por 56 dosis (dosis 1/56)
- Piridoxina tableta 50 mg, dar 1 tab VO cada día por 30 días (FI: 04/09/2024) (dosis 1/30)
- Paracetamol 1gr IV cada 8 horas :::SUSPENDER:::
- Acetaminofen 1gr VO cada 8 horas :::NUEVO::: ::RAZON NECESARIA:::
- Enoxaparina 40 Mg/subcutánea cada 24 h:::Nuevo::: FS:03/09/2024

- Valoración por psicología, trabajo social FS: 03/09/2024 :::NUEVO:::

- SS/ Cultivo Esputo
- SS/ Gases arteriales(paciente no se deja tomar muestra) :::NUEVO:::
- P/ PCR para tuberculosis, cultivo para tuberculosis en medio líquido, VH(paciente no se deja tomar la muestra), tgo, tgp.
- P/ Tomografía de torax
- P/Baciloscopia seriada

- Cuidados de enfermería
- Control de signos vitales y avisar cambios

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

Complicaciones:

NINGUNNA

Servicio de Egreso: 000001|Urgencia

Fecha de Egreso: 04/09/2024 11:18

Motivo de Salida: Voluntad

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A153 : TUBERCULOSIS DEL PULMON , CONFIRMADA POR MEDIOS NO ESPECIFICADOS

Diagnóstico Relacionado 1: D508 : OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:

Tratamiento Farmacológico:

PACIENTE QUIEN FIRMA ALTA VOLUNTARIA. SE EXPLICA CUADRO Y POSIBLES COMPLICACIONES.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:19:32 p. m.

Admisión: AD998670

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: JOSE LUIS ESTARITA FERRER

EPICRISIS**Recomendaciones Adicionales:**

PACIENTE QUIEN FIRMA ALTA VOLUNTARIA SE EXPLICA CUADRO Y POSIBLES COMPLICACIONES.

Aplica Cuidados de Enfermería: No



JORGE ARMANDO YEPES CARO

MEDICINA INTERNA

CC.1051815934 - RM.RM:23859

CC:1051815934